



	Người biên soạn	Người kiểm tra	Người phê duyệt
Họ và tên	CKI.XN.Nguyễn Thái Hòa	Ths.Nguyễn Thị Bình	Ts.Vũ Tuấn Anh
Ký tên			 
Chức vụ	KTV.Trưởng khoa	Trưởng khoa	Giám đốc
Ngày	05/01/2026	10/01/2026	21../01/2026

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

[illegible]

1. Mục đích

Hướng dẫn này được xây dựng để cung cấp thông tin và hướng dẫn nhân viên xét nghiệm nhằm đảm bảo an toàn trong khoa.

2. Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho Khoa Vi sinh-Miễn dịch.

3. Trách nhiệm

Lãnh đạo Khoa và nhân viên có trách nhiệm tuân thủ quy trình này.

4. Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt

4.1. Định nghĩa

- **Khử nhiễm (Decontamination)**: Bao gồm tiết trùng, khử trùng và bất hoạt. Quá trình khử nhiễm đối với khu vực xét nghiệm, thiết bị, dụng cụ và vật liệu nhằm loại bỏ yếu tố nguy cơ và tránh nhiễm chéo: Khử trùng bề mặt làm việc, khử nhiễm thiết bị hoặc có thể tiết trùng.

- **Tiệt trùng (Sterilization)**: Là tiêu diệt tất cả các vi sinh vật và các dạng vi sinh vật (bao gồm bào tử...).

- **Khử trùng (Disinfection)**: Mức độ thấp hơn tiết trùng, có thể diệt hầu hết tất cả vi sinh vật nhưng không diệt hết tất cả dạng vi sinh vật (bào tử...).

- **Bất hoạt (Antisepsis)**: Làm mất khả năng gây bệnh của vi sinh vật.

4.2. Từ viết tắt

- **ATSH**: An toàn sinh học
- **BHCN**: Bảo hộ cá nhân
- **KVXN**: Khu vực xét nghiệm
- **TNGB**: Tác nhân gây bệnh

5. Nội dung thực hiện

5.1. Thực hành an toàn

5.1.1. An toàn cháy nổ

- Thực hiện theo “Nội quy Tiêu lệnh chữa cháy của Bộ Công an và quy định phòng cháy chữa cháy” của bệnh viện.
- Nhân viên Khoa phải tham gia đầy đủ lớp tập huấn an toàn phòng chống cháy nổ do bệnh viện tổ chức và nắm rõ các nguyên nhân chính gây cháy phổ biến, phân loại cháy,

Phiên bản: 1.0	Trang 2/15
Ngày ban hành:/01/2026	

sử dụng thiết bị dập lửa, xử lý khi có cháy và thoát hiểm.

- Nhân viên không tự ý mang vật liệu dễ gây cháy/nổ vào khu vực xét nghiệm mà không được phép.

5.1.2. An toàn về điện

- Hạn chế sử dụng ổ cắm nối dài, trong trường hợp cần thiết thì phải sử dụng ổ cắm nối dài có 3 chấu (không được gỡ bỏ đầu nối đất), không sử dụng cho thiết bị có công suất cao tránh quá tải cho ổ cắm nối.

- Không sử dụng dây dẫn, phích và dây nối dài nếu có dấu hiệu bong tróc lớp cách điện hay hư hỏng.

- Không để ổ cắm trực tiếp xuống nền nhà, phải để cách sàn từ 40cm và không để gần nơi ẩm ướt như chỗ rửa dụng cụ, rửa tay...

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện bảo dưỡng thiết bị, nhất là đối với các thiết bị an toàn như tủ an toàn sinh học, máy ly tâm, nồi hấp tiệt trùng...

- Không để tay ướt khi thao tác với thiết bị điện.

- Trong trường hợp bị điện giật (dù nhỏ) hoặc xuất hiện khói hay mùi khét, lập tức đánh dấu thiết bị **“KHÔNG SỬ DỤNG”** và đề nghị sửa chữa.

5.1.3. An toàn hóa chất

- Phân khu để hóa chất theo nhóm và có chú thích cần thiết tại khu vực bảo quản hóa chất đó. Với mỗi loại hóa chất phải có thông tin an toàn hóa chất: Thông tin về tính chất vật lý, hóa học, tương tác với hóa chất khác, điều kiện bảo quản, cháy nổ, nguy cơ đối với sức khỏe, chú ý sử dụng an toàn...

Quy định chung đối với những hoá chất kỵ nhau

HÓA CHẤT	NHỮNG HÓA CHẤT KỴ
Các kim loại kiềm như Na, K, Cs, Li	CO ₂ , hydrocacbon đã được clo hoá, nước
Các Halogens	Ammoni, acetylene, các hydrocarbon
Axit acetic, hydrogen sulfide, aniline, các hydrocarbon, axit sulfuric	Các chất ôxy hoá như axit chromic, axit nitric, peroxides, permanganates

- Nhân viên phải phân loại hóa chất khi nhận và đảm bảo chúng được sắp xếp theo nhóm không kỵ nhau.

- Tất cả các hóa chất tự pha để dùng trong khoa phải được đựng trong lọ có nắp đậy, có

Phiên bản: 1.0	Trang 3/15
Ngày ban hành:/01/2026	

nhân ghi đầy đủ thông tin: Tên hóa chất, nồng độ, điều kiện bảo quản, người pha, ngày pha, hạn sử dụng.

- Kiểm tra hóa chất định kỳ để loại bỏ những hóa chất đã hết hạn, không còn sử dụng và điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu hủy vật tư mã số: XN-BM 5.7.2/05.

- Khi thao tác với hóa chất phải sử dụng đồ bảo hộ lao động và phải tuân thủ theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Tùy theo mức độ nghiêm trọng, tiếp tục thực hiện theo quy trình kiểm soát sự không phù hợp mã số: XN-QTQL 5.10.1.

5.1.4. An toàn sinh học

5.1.4.1. Phòng tránh lây nhiễm dịch cơ thể

- Khi vận chuyển mẫu, ngăn ngừa rò rỉ hoặc vỡ mẫu, người đóng gói/vận chuyển mẫu phải được tập huấn về an toàn. Đảm bảo phiếu yêu cầu xét nghiệm không đặt cùng với mẫu, có thể cho vào túi nilon và dán bên ngoài thùng đựng mẫu. Trong trường hợp phiếu yêu cầu xét nghiệm bị nhiễm bẩn có thể viết lại phiếu và hủy phiếu đã nhiễm bẩn.

- Phải sử dụng trang phục và thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp khi thao tác với mẫu bệnh phẩm hoặc lấy mẫu cho bệnh nhân. Sau khi sử dụng đồ bảo hộ cá nhân, phải bỏ vào túi rác thải chuyên dụng.

- Mặc trang phục bảo hộ cá nhân trong suốt thời gian làm việc tại KVXN, không mặc trang phục bảo hộ của khu vực này sang khu vực khác và không mặc trang phục này ra ngoài khu vực xét nghiệm đó.

- Nhân viên phải được đào tạo về ATSH mới được thực hiện xét nghiệm với TNGB.

5.1.4.2. An toàn vận chuyển mẫu

- Vận chuyển an toàn mẫu bệnh phẩm đến phòng xét nghiệm đòi hỏi thận trọng trong việc chuẩn bị, đóng gói cũng như vận chuyển bệnh phẩm, tránh những sự cố như đổ vỡ dẫn tới phát tán bệnh dịch.

- Bệnh phẩm thu thập cho chẩn đoán tác nhân gây bệnh được đóng gói theo nguyên tắc 3 lớp:

+ Lớp thứ 1: Ống/lọ chứa mẫu trực tiếp

- Ống phải chắc chắn và có nắp kín. Đảm bảo nắp ống đựng mẫu không bị kênh khi chứa mẫu và phải có thông tin nhận dạng trên ống (tên, tuổi và ngày lấy mẫu).

Phiên bản: 1.0	Trang 4/15
Ngày ban hành:/01/2026	

+ Lớp thứ 2: Hộp/túi chứa các ống đựng mẫu

- Hộp/túi phải chắc chắn, kín tuyệt đối và có khả năng hấp thụ dung dịch nếu ống mẫu bị đổ/vỡ.

+ Lớp thứ 3: Thùng/hộp chứa các hộp có ống mẫu bệnh phẩm (thùng nên là loại có lớp vỏ xốp và lớp vỏ bìa cứng bên ngoài).

- Thùng phải chắc chắn, có khả năng cách nhiệt. Khi vận chuyển mẫu phải đảm bảo thùng chứa bệnh phẩm phải được đặt chắc chắn, tránh va đập.
- Bên ngoài thùng có thể đính kèm phiếu yêu cầu xét nghiệm (không để chung phiếu với bệnh phẩm) hoặc có thể để giữa lớp vỏ xốp và lớp vỏ bìa cứng (đặt trên nắp thùng xốp rồi mới đóng lớp bìa cứng).

5.1.5. An toàn cho người

5.1.5.1. Trang bị bảo hộ cá nhân

- Sử dụng trang bị BHCN nhằm ngăn ngừa tiếp xúc hóa chất độc hại, tránh những tổn thương gây ra do các yếu tố vật lý, phơi nhiễm với TNGB và các mối nguy hiểm có thể xảy ra tại nơi làm việc.

- Khoa cần trang bị đầy đủ BHCN thiết yếu, tùy theo mức độ nguy hiểm của công việc.

+ Sử dụng đúng cách, đúng thời điểm, tùy theo nguy cơ nhằm đạt hiệu quả bảo vệ cao nhất.

+ Cán bộ lấy mẫu phải được đào tạo về cách thức, nguyên lý sử dụng các loại BHCN.

+ Trang bị BHCN giúp làm giảm nhưng không loại bỏ được hoàn toàn nguy cơ lây nhiễm tác nhân gây bệnh.

Trang phục bảo hộ cá nhân

- Bảo hộ phần đầu: Mũ trùm đầu, khẩu trang y tế/khẩu trang có hiệu quả lọc cao, kính/mặt nạ.

- Bảo hộ phần thân: Bộ quần và áo; hoặc bộ áo liền quần; tạp dề (nếu cần).

- Bảo hộ tay chân: Găng tay, bao giày hoặc ủng.

Nguyên tắc mặc/cởi trang bị bảo hộ cá nhân

- Nên xịt cồn lên toàn bộ bề mặt trang bị BHCN trước khi cởi bỏ.

- Lớp găng tay ngoài cùng dễ lây nhiễm nên phải tháo trước tiên.

- Phần đầu (khẩu trang, mũ trùm đầu) cần được bảo vệ nhiều nhất nên cần mặc trước

và cởi bỏ ra sau cùng.

- Khi cởi bỏ phần thân (quần áo rời hoặc áo liền quần) thì quay mặt trong ra ngoài, cởi bỏ áo trước rồi đến quần và khi cởi bỏ quần thì có thể kéo cả phần bao giày.

5.1.5.2. An toàn cho nhân viên

- Tất cả nhân viên phải tuân thủ đầy đủ quy định an toàn của Khoa Vi sinh-Miễn dịch.

5.1.5.3. An toàn cho người ngoài

- Các cá nhân đến làm việc trực tiếp tại phòng xét nghiệm gồm: Nhân viên của Khoa khác, cán bộ/sinh viên thực tập, người thực hiện các công việc cung cấp dịch vụ tại phòng xét nghiệm (người dọn vệ sinh, kỹ sư sửa chữa...) phải có người của khoa đi cùng và được hướng dẫn sử dụng BHCN phù hợp.

- Khoa phổ biến các quy định chung: Quy định ra vào khoa, hướng dẫn thiết bị, sử dụng bảo hộ cá nhân...).

- Giải thích mức nguy hiểm mà họ có thể bị phơi nhiễm, đối phó nếu xảy ra phơi nhiễm và vị trí thiết bị an toàn.

- Hỗ trợ khách sơ tán trong trường hợp khẩn cấp.

5.1.6. Kiểm tra an toàn

5.1.6.1. Kiểm tra an toàn nơi làm việc

- Kiểm tra an toàn là công việc quan trọng nhằm đánh giá nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra tại khu xét nghiệm.

- Khoa Vi sinh-Miễn dịch phối hợp Khoa chống nhiễm khuẩn tiến hành kiểm tra định kỳ 1 năm/lần theo tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, thực hành an toàn sinh học, khử nhiễm và xử lý chất thải, giám sát y tế, phòng ngừa, xử lý và khắc phục sự cố an toàn sinh học. Các nội dung này có thể được thay đổi cho phù hợp với thực tế.

- Kết quả kiểm tra được lưu tại Khoa và báo cáo lãnh đạo bệnh viện.

5.1.7. Sự cố an toàn

5.1.7.1. Xử lý sự cố

- Sự cố làm đổ bệnh phẩm

+ Ngay lập tức cảnh báo và đặt dấu hiệu cảnh báo chú ý cho mọi người ở gần khu vực bị đổ mẫu.

+ Sử dụng bộ xử lý sự cố đổ mẫu, dùng khăn/giấy thấm phủ lên mẫu bị đổ, đổ chất khử nhiễm để khoảng 30 phút cho chất khử nhiễm phát huy tác dụng diệt khuẩn tối đa.

Phiên bản: 1.0	Trang 6/15
Ngày ban hành:/01/2026	

- Loại bỏ dụng cụ bị đổ/vỡ, khăn/giấy thấm và vật sắc nhọn vào túi đựng chất thải lây nhiễm.

+ Lau sạch khu vực có mẫu bị đổ nhiều lần và có thể tiếp tục công việc sau khi hoàn tất quá trình khử nhiễm.

+ Báo cáo sự việc với QLCL. Tùy theo mức độ nghiêm trọng, tiếp tục thực hiện theo quy trình kiểm soát sự không phù hợp mã số: XN-QTQL 5.10.1.

- Sự cố bị vật sắc nhọn đâm vào tay/chân

+ Báo cho đồng nghiệp làm việc gần đó (nếu có).

+ Vết thương chảy máu do kim tiêm, cần xối ngay vết thương dưới vòi nước trong vòng 5 - 10 phút, không nặn bóp vết thương mà phải để tự chảy máu. Cần rửa kỹ bằng xà phòng sát khuẩn và nước sạch.

+ Rời khỏi khoa và đến cơ sở y tế khám và xét nghiệm mức độ phơi nhiễm nếu cần.

+ Nhân viên báo cáo cho QLCL, tùy theo mức độ nghiêm trọng, tiếp tục thực hiện theo quy trình kiểm soát sự không phù hợp mã số: XN-QTQL 5.10.1.

- Sự cố mất điện khi đang làm việc với TNGB

+ Trong trường hợp có máy phát điện dự phòng, nhân viên ở lại khu vực xét nghiệm tránh di chuyển và chờ tới khi có điện trở lại để tiếp tục làm việc.

+ Trong trường hợp máy phát điện không hoạt động, nhân viên cần cắt mẫu hoặc bất hoạt tránh không làm phát tán TNGB.

+ Tùy theo mức độ nghiêm trọng, tiếp tục thực hiện theo quy trình kiểm soát sự không phù hợp mã số: XN-QTQL 5.10.1.

5.1.7.2. Báo cáo sự cố

- Khi xảy ra sự cố/tai nạn, nhân viên báo cáo sự cố một cách chi tiết, chính xác. Trong trường hợp sự cố nghiêm trọng nhân viên không thể tiếp tục làm việc hoặc cần điều trị, thì QLCL/QLKT sẽ thu thập thông tin, báo cáo cho lãnh đạo Khoa và báo cáo phòng quản lý chất lượng của bệnh viện.

- Xem xét các yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và xác định hành động cần thiết để khắc phục.

- Bảo đảm báo cáo sự cố xảy ra được hoàn tất và đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự cố theo quy trình kiểm soát sự không phù hợp mã số: XN-QTQL 5.10.1.

- Khi cần, sử dụng các nguồn lực khác làm nhân chứng tai nạn, có thể mời đại diện

Phiên bản: 1.0	Trang 7/15
Ngày ban hành:/01/2026	

công đoàn, đại diện y tế và an toàn. Quản lý chất lượng có thể hỗ trợ điều tra khi cần.

5.1.7.3. Điều tra sự cố.

- Mức độ điều tra cần thiết phụ thuộc phần lớn vào mức độ nguy hiểm hoặc tính nguy hiểm tiềm tàng của hậu quả của tai nạn.
- Bản chất tai nạn: Tai nạn sơ cứu, tai nạn cần hỗ trợ y tế, thiệt hại thiết bị và tổn thương nghiêm trọng hoặc tử vong (nguy hiểm đến sự sống, mất ý thức, mất máu đáng kể, bong phần lớn cơ thể, mất thị giác 1 mắt...).

Khi nhân viên bị tổn thương cần có sự chăm sóc y tế:

- + Giữ an ninh và quản lý hiện trường tai nạn, nếu cần. Nếu có thể, trung hoà bất cứ mối nguy hiểm nào có thể hiện diện.
- + Thu thập tên của tất cả những người chứng kiến tai nạn hoặc biết về tai nạn.
- + Không khởi động lại bất cứ máy móc nào liên quan trong tai nạn hoặc làm xáo trộn chứng cứ thực thể trừ khi được người giám sát/quản lý cho phép dọn dẹp. Khi dọn dẹp tiến hành xử lý đối với các đồ vỡ theo quy trình xử lý sự cố (mục 4.1).
- Việc điều tra có thể gồm:
 - + Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
 - + Lời khai nhân chứng.
 - + Vẽ, chụp ảnh và hoặc miêu tả mọi thiết bị liên quan.
 - + Các quy trình làm việc.
 - + Tài liệu chương trình đào tạo nhân viên về các vấn đề liên quan.

5.2. Phòng ngừa phơi nhiễm

5.2.1. Phòng ngừa phơi nhiễm

Các nguy cơ chính: Virus viêm gan B (HBV), virus suy giảm miễn dịch ở người (HIV), virus viêm gan C (HCV)...

- Các loại mẫu bệnh phẩm cần lưu ý: Máu, huyết thanh, huyết tương, dịch não tủy, dịch màng phổi, dịch ngoáy họng, dịch tỵ hầu, đờm, nước bọt, phân, chất nôn...
- Lãnh đạo Khoa sẽ phổ biến chi tiết với nhân về những nguy cơ khi làm việc với TNGB.
- Trước khi tuyển dụng nhân viên cần được kiểm tra sức khỏe, lưu hồ sơ về tiêm chủng, tiền sử bệnh tật (nếu có).
- Khoa phải tìm hiểu và đánh giá tính sẵn có của vắc xin và/hoặc điều trị nội khoa

Phiên bản: 1.0	Trang 8/15
Ngày ban hành:/01/2026	

trong trường hợp bị phơi nhiễm.

- Nhân viên cần được tạo miễn dịch chủ động (tiêm vắc xin) với loại TNGB liên quan đến công việc, nếu chưa có loại vắc xin phòng ngừa tác nhân đó (HIV) thì có thể tiêm vắc xin cho các bệnh cơ hội (tiêm vắc xin phòng lao, viêm gan...) khi bị phơi nhiễm với tác nhân đó.

5.2.2. Giám sát sức khỏe

- Trong quá trình làm việc

+ Những người có tính nhạy cảm cao (ví dụ: Phụ nữ có thai hay người bị tổn thương miễn dịch) được chuyển sang công việc ít hoặc không có mức độ nguy hiểm cao trong PXN. Phụ nữ tuổi sinh đẻ cần được cảnh báo các nguy cơ bị phơi nhiễm với một số vi sinh vật, ví dụ vi rút Cúm, Sởi, Rubella.

+ Sử dụng các thiết bị và bảo hộ cá nhân hiệu quả và phù hợp với loại TNGB.

+ QLCL phải quản lý các tài liệu về ngày nghỉ ốm và nghỉ việc của nhân viên.

+ Nhân viên phải tham gia khám sức khỏe định kỳ hằng năm do Phòng khám tổ chức.

- Khi bị phơi nhiễm.

+ Khi nhân viên bị nghi ngờ phơi nhiễm với TNGB khi đang làm việc, Khoa có thể thực hiện kiểm tra phơi nhiễm cho nhân viên (bằng KTXN đang thực hiện tại khoa...).

+ Thông báo ngay cho Lãnh đạo Khoa để tiếp tục tiến hành theo mục 4.1.7 sự cố an toàn.

5.2.3. Thực hành kỹ thuật vi sinh tốt

- *Nhận thức*

+ Nắm vững mọi quy trình và hướng dẫn của Khoa.

+ Tổn thương xảy ra có thể xuất phát từ việc xử lý bất cẩn, thận trọng khi xử lý dụng cụ xét nghiệm/vật sắc nhọn chứa TNGB.

+ Vị trí vòi rửa mắt, vòi hoa sen trên đầu và cầm tay, bộ lau dọn tràn vãi.

+ Quy trình hoạt động cho mọi trang thiết bị an toàn và khẩn cấp.

- *An toàn xử lý mẫu*

+ Dụng cụ đựng mẫu có thể bằng thủy tinh hoặc nhựa tổng hợp, không được rò rỉ, không để mẫu dính ngoài dụng cụ đựng mẫu. Dụng cụ đựng mẫu cần dán nhãn chính xác để dễ nhận biết.

+ Khi di chuyển mẫu giữa các phòng, phải đậy kín dụng cụ chứa mẫu tránh không để

Phiên bản: 1.0	Trang 9/15
Ngày ban hành:/01/2026	

cho dung dịch chạm nắp, có thể đặt vào hộp đựng mẫu.

+ Khi nhận và mở mẫu cần phải có kiến thức về các nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe và cần được đào tạo để thực hiện các phòng ngừa cơ bản, đặc biệt khi xử lý các vật chứa bị vỡ hoặc rò rỉ.

+ Các dụng cụ chứa mẫu quan trọng nên mở trong tủ an toàn sinh học và có sẵn các chất diệt trùng.

- Sử dụng pipet

+ Luôn sử dụng dụng cụ hỗ trợ hút mẫu, nên sử dụng pipet có nút bông không thấm để giảm làm nhiễm bẩn các thiết bị hút.

+ Không thổi không khí vào trong chất lỏng có chứa các tác nhân nhiễm trùng.

+ Dụng cụ nhiễm khuẩn cần ngâm chìm hoàn toàn trong một chất khử trùng và trong thời gian thích hợp trước khi thải bỏ.

+ Nên đặt giấy thấm trên bề mặt làm việc và sau khi sử dụng cần hủy bỏ như chất thải nhiễm trùng. Khu vực làm việc cần tẩy trùng bằng chất tẩy thích hợp vào cuối mỗi buổi làm việc.

- Tránh để các vật nhiễm trùng dính vào cơ thể

+ Tránh chạm tay có gắng vào miệng, mắt vùng hở trên cơ thể.

+ Không ăn/uống, ngậm bút và trang điểm.... trong khu vực xét nghiệm.

+ Nếu cần thiết có thể dùng tấm chắn nhựa để bảo vệ mắt, mắt và miệng trong thao tác có thể gây văng bắn các vật có nguy cơ nhiễm khuẩn.

+ Những vật dụng dùng một lần nên được thải bỏ trong vật chứa chuyên dụng chống thấm/chống thủng có nắp đậy.

+ Nên khử khuẩn mặt ngoài dụng cụ lưu giữ khi cất mẫu hoặc lấy ra khỏi nơi bảo quản.

+ Nên mang đồ bảo vệ mắt và tay khi cất/lấy ra mẫu khỏi nơi bảo quản.

5.2.4. Vệ sinh và khử nhiễm Khoa Vi sinh-Miễn dịch.

- Khu vực xét nghiệm, thiết bị

+ Làm sạch bề mặt bàn, tủ an toàn sinh học trước và sau khi làm xét nghiệm.

+ Làm sạch khu vực xét nghiệm: Loại bỏ chất thải của khoa; lau sàn khoa; tổng vệ sinh khoa gồm làm sạch thiết bị và khu xét nghiệm.

+ Có thể sử dụng các loại hóa chất như: Cồn 70⁰, dung dịch tẩy rửa, cloramin 0.5%...

Phiên bản: 1.0	Trang 10/15
Ngày ban hành:/01/2026	

- + Tiến hành khử trùng và tiệt trùng khi đánh đổ lượng lớn bệnh phẩm để ngăn chặn khả năng lây lan hoặc khi thay đổi tác nhân xét nghiệm tránh nhiễm lẫn nhau.
- + Khử trùng bề mặt thiết bị do nhân viên tiến hành bằng cồn 70⁰, dung dịch chứa 3% hydrogen peroxide (H₂O₂).
- + Riêng tiệt trùng khoa bằng xông hơi formaldehyde do khoa kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện (nếu có yêu cầu).

- Tủ an toàn sinh học.

- + Nhân viên cần dọn tủ an toàn sinh học trước khi tiệt trùng, nếu muốn tiệt trùng cả dụng cụ đang dùng trong tủ an toàn sinh học thì cần lưu ý dụng cụ phải chịu được formaline (không gỉ, không dễ bị ăn mòn). Ngoài ra trong tủ không nên để các loại dung dịch, giấy.
- + Để ngăn chặn khả năng lây lan khi đánh đổ lượng lớn bệnh phẩm, tránh nhiễm lẫn nhau khi thay đổi TNGB.

- Dụng cụ xét nghiệm

- + Cần thực hiện sau mỗi lần sử dụng xong các dụng cụ xét nghiệm.
- + Các dụng cụ cần tiệt trùng để tái sử dụng: Ống nghiệm, chai lọ thủy tinh, hộp inox...
- + Phân loại tiệt trùng: Dụng cụ sạch và dụng cụ nhiễm TNGB.
- + Tiệt trùng bằng nồi hấp ưót đối với các dụng cụ nhiễm TNGB, chú ý mở lỏng nút các loại chai, lọ và sắp xếp sao cho hơi nước và các chất khi có thể tiếp xúc với mọi bề mặt của dụng cụ.
- + Ngâm vào nước hoặc dung dịch thích hợp.
- + Rửa sạch bằng xà phòng với bàn chải thích hợp, tráng lại nhiều lần bằng nước loại ion hoặc nước cất.
- + Làm khô dụng cụ và tiệt trùng lại trước khi sử dụng bằng thiết bị sấy khô/hấp ưót riêng cho dụng cụ sạch.

5.3. An toàn chất thải

5.3.1. Quản lý chất thải

- Nhân viên cần được huấn luyện để có thể phân loại chất thải theo nhóm nguy cơ và theo màu sắc của dụng cụ chứa chất thải.
- *Quy định về màu sắc*
- + Màu vàng đựng chất thải lây nhiễm.

Phiên bản: 1.0	Trang 11/15
Ngày ban hành:/01/2026	

- + Màu đen đựng chất thải hoá học nguy hại và chất thải phóng xạ.
- + Màu xanh đựng chất thải thông thường và các bình áp suất nhỏ.
- + Màu trắng đựng chất thải tái chế.

- Tiêu chuẩn cho dụng cụ đựng chất thải

+ Túi đựng rác thải làm bằng nhựa có thành dày, bên ngoài túi phải có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi. Các túi này thải phải tuân theo hệ thống màu đã được quy định và sử dụng đúng mục đích.

+ Dụng cụ đựng chất thải sắc nhọn phải bảo đảm: Không bị xuyên thủng, có khả năng chống thấm, có nắp đóng mở dễ dàng. Màu vàng.

+ Thùng đựng chất thải làm bằng nhựa thành dày và cứng có nắp đậy, màu sắc thùng đựng chất thải phải tuân theo quy định màu sắc và chứa các túi rác thải màu tương ứng

- Biểu tượng chỉ thị loại chất thải

Mặt ngoài túi, thùng đựng một số loại chất thải nguy hại và chất thải dễ tái chế phải có biểu tượng chỉ loại chất thải phù hợp.

 Biểu tượng nguy hại sinh học	 Biểu tượng chất phóng xạ
 Biểu tượng chất gây độc tế bào	 Biểu tượng chất thải có thể tái chế

5.3.2. Phân loại và xử lý chất thải

5.3.2.1. Chất thải thông thường

- Phân loại chất thải

- + Chất thải sinh hoạt phát sinh từ phòng thí nghiệm (không dính máu, dịch sinh học và các chất hoá học nguy hại) như chai lọ thủy tinh, các vật liệu nhựa, giấy...
- + Chất thải phát sinh từ các công việc hành chính: Giấy, báo, tài liệu, vật liệu đóng gói, thùng các tông, túi nilon, túi đựng phim.

Phiên bản: 1.0	Trang 12/15
Ngày ban hành:/01/2026	

+ Chất thải ngoại cảnh: Lá cây và rác từ các khu vực ngoại cảnh.

- *Thu gom và xử lý*

+ Chất thải thông thường được đựng trong thùng/túi nilon màu xanh, lượng chất thải chứa trong mỗi túi chỉ đầy tới 3/4 túi.

+ Với chất thải có thể tái chế:

- Cho rác thải vào túi màu trắng có biểu tượng tái chế và bỏ túi này vào thùng chứa chất thải màu trắng có biểu tượng tái chế tại nơi tập kết chất thải của Phòng khám.

+ Với chất thải không thể tái chế:

- Cho rác thải vào túi màu xanh và bỏ túi này vào thùng chứa chất thải màu xanh tại nơi tập kết chất thải của bệnh viện.

5.3.2.2. Chất thải lây nhiễm

- *Phân loại chất thải*

+ Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn (loại B): Là chất thải bị thấm máu, thấm dịch sinh học của cơ thể và các chất thải phát sinh từ buồng bệnh.

+ Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao (loại C): Là chất thải phát sinh trong các phòng xét nghiệm như: Bệnh phẩm và dụng cụ đựng, dính bệnh phẩm.

+ Chất thải giải phẫu (loại D): Bao gồm các mô, cơ quan, bộ phận cơ thể người, động vật thí nghiệm.

- *Thu gom và xử lý*

+ Chất thải lây nhiễm được đựng trong thùng/túi nilon màu vàng, lượng chất thải chứa trong mỗi túi chỉ đầy tới 3/4 túi.

+ Cho rác thải vào túi màu vàng và bỏ túi này vào thùng chứa chất thải màu vàng tại nơi tập kết chất thải của Phòng khám.

5.3.2.3. Chất thải sắc nhọn

- *Phân loại chất thải*

+ Chất thải sắc nhọn (loại A): Là chất thải có thể gây ra các vết cắt hoặc chọc thủng, có thể nhiễm khuẩn, bao gồm: Bơm kim tiêm, đầu sắc nhọn của dây truyền, lưỡi dao mổ, đinh mổ, cưa, các ống tiêm, mảnh thủy tinh vỡ và các vật sắc nhọn khác sử dụng trong các loại hoạt động y tế.

- *Thu gom và xử lý*

Phiên bản: 1.0	Trang 13/15
Ngày ban hành:/01/2026	

- + Chất thải sắc nhọn phải được đựng trong thùng/hộp màu vàng, không bị xuyên thủng có khả năng chống thấm, và có nắp đóng mở dễ dàng.
- + Chất thải lây nhiễm được đựng trong thùng/hộp màu vàng, lượng chất thải chứa trong mỗi thùng/hộp chỉ đầy tới 3/4 thùng/hộp.
- + Cho rác thải vào thùng/hộp màu vàng và bỏ thùng/hộp này vào thùng chứa chất thải màu vàng tại nơi tập kết chất thải của Phòng khám.

5.3.2.4. Chất thải độc hại

- Phân loại chất thải

- + Chất hóa học nguy hại: Chất gây độc tế bào, vỏ các chai/lọ hoặc dụng cụ dính thuốc gây độc tế bào, các chất tiết từ người bệnh được điều trị bằng hóa trị liệu.
- + Chất thải chứa kim loại nặng: Thủy ngân (từ nhiệt kế, huyết áp kế thủy ngân bị vỡ, chất thải từ hoạt động nha khoa), chì (từ tấm gỗ bọc chì hoặc vật liệu tráng chì sử dụng trong ngăn tia xạ từ các khoa chẩn đoán hình ảnh, xạ trị).
- + Chất thải phóng xạ: Gồm các chất thải phóng xạ rắn, lỏng và khí phát sinh từ các hoạt động chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu và sản xuất.

- Thu gom và xử lý

- + Chất thải lây nhiễm được đựng trong túi màu đen, lượng chất thải chứa trong mỗi túi chỉ đầy tới 3/4 túi.
- + Cho rác thải vào túi màu đen và bỏ túi này vào thùng chứa chất thải màu đen tại nơi tập kết chất thải của Phòng khám.

6. Lưu trữ hồ sơ

Tất cả các nội dung được lưu trữ trong hồ sơ theo dõi môi trường. Thời gian lưu 20 năm.

- Đánh giá yếu tố rủi ro Khoa Xét nghiệm XN-BM 5.12.1/06

7. Tài liệu liên quan

- Quy trình hướng dẫn soạn thảo quy trình chuẩn: XN-QTQL 5.2.2
- Quy trình sự không phù hợp XN-QTQL 5.10.1
- Quy trình quản lý hồ sơ XN-QTQL 5.2.3
- Quy trình quản lý thông tin XN-QTQL 5.8.1

8. Tài liệu tham khảo

- Cẩm nang an toàn sinh học phòng thí nghiệm, Tổ chức Y tế thế giới, 2004.

Phiên bản: 1.0	Trang 14/15
Ngày ban hành:/01/2026	

- Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn bảo đảm chất lượng xét nghiệm đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Thông tư số 20/2021/TT-BYT của Bộ Y tế: Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

- Quyết định Số: 5530/QĐ-BYT về “Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2017 về Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học.

- TCVN ISO 15189:2014 (ISO 15189:2012) Phòng thí nghiệm Y tế – Yêu cầu về chất lượng và năng lực, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 2014.

- ISO 15189:2012, Medical laboratories - Requirements for quality and competence, 2012.

Phiên bản: 1.0	Trang 15/15
Ngày ban hành:/01/2026	